АНА МЕН БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫ

Кусанова Айкерим Максутовна.
Утебалиева Гулназ Магжановна.
Дәрігер педиатр
Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі,
«Педиатрия» пәні оқытушылары.

ӨЗЕКТІЛІГІ

Халықтың қалып өсіп – өнуін қамтамасыз ету, және өмір сүруі сапасын арттыру үшін Қазақстанда да адам өмірі барлығынан да маңызды. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында көптеген арнайы бағдарламалар қабылданып келеді. Әсіресе ана мен бала денсаулығына ерекше мән берілуде. Қазақ педиатрия ғылыми-зерттеу институтының акушерлік-гинекология бөлімінде,орталықтың ғылыми жұмыстарының бағыты – еліміздегі әйелдердің денсаулығын сақтау, екіқабат әйелдердің өте қауіпті тобындағыларды дер кезінде емдеу, оның тәсілдері мен стратегиясын, аналардың және іштегі нәрестенің сырқаты мен шетінеуін азайту, нәрестенің мезгілінен бұрын туу себептерін, туысынан болған ауытқулардың таралу аймағы мен генетик байланысын зерттеу, бедеу әйелдерді емдеу қызметін атқарып келеді екен.

ЗЕРТТЕУ БАРЫСЫ.

Қазақстан Республикасындағы 2018-2020 жыл аралығындағы нәрестелік өлім-жітімнің көрсеткіші мен нәтижесі.

«Қазақстан Республикасында педиатрлық көмекті көрсетуді ұйымдастыру стандарттарын бекіту туралы»ҚР Денсаулық сақтау Министрінің 15.03.2022 ж.№ҚР ДСМ-25 бұйрығы көрсетілген. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жыл 14 шілдедегі Үкіметтің кеңейтілген отырысында ана мен бала өлімі туралы қозғап өтті «Үкіметтің басты міндетінің бірі – ана мен баланың денсаулығын сақтау.Өкінішке қарай, сәбилердің өлімі көбейді. Ана өлімі де өсуде. Мен перинаталдық қызметтің жай-күйін тексеруге тапсырма бердім. Оның қорытындысы бойынша тиісті шаралар қабылдануы керек еді. Бірақ барлық жұмыс аудит деңгейінде тоқтап қалды.Қазіргі перзентханалардың көбі халықаралық стандарттарға сай емес. Сондықтан шұғыл шаралар қабылдап, осы мәселені шешу қажет. Жалпы, денсаулық сақтау саласы туралы айтар болсақ, мұнда түйткілді мәселелер көп, дегенмен, бұл көрсеткіш төмендеп келеді. Бірақ әлі де жоғары, сондай-ақ дамыған елдердің деңгейінен айтарлықтай көп.» - деді

Нәрестелердің өлімінің негізгі себептеріне : асфиксия, пневмония, туа біткен ақаулар, мерзімді туылу асқынулары, мысалы, аномалды көрініс ұрықтың кіндік пролапсы,немесе ұзақ босану,жатыр ішілік инфекция,диарея ,безгек ,қызылша және дұрыс тамақтанбау. Ең көп кездесетін алдын-алу себептерінің бірі - жүктілік кезінде темекі шегу, пренатальды күтімнің болмауы, жүктілік кезіндегі алкогольді ішімдік ішу және есірткіні қолдану сонымен қатар асқынулар тудырады. Өлім-жітімге көптеген экологиялық факторларда ықпал етеді, мысалы, ананың білім деңгейі, қоршаған орта жағдайы, саяси және медициналық инфрақұрылымы, экологиялық және әлеуметтік кедергілер, негізгі медициналық ресурстардың жетіспеушілігі ықпал етеді . Статистика бойынша төменде көрсетілген көрсеткіштерге назар аударсақ:

Нәрестелердің өлім-жітім коэффициент көрсеткіші - 1 жасқа дейінгі сәби өлімінің өлшем деңгейі.1000 туылудың ішіндегі 1 жасқа дейінгі сәби өлімінің жылдық санағымен есептеледі.

Диаграмма 1. 2000 – 2020 жж. аралығындағы жалпы өлім-жітімнің саны.



Қорытынды: 2000 – 2020 жж. аралығындағы жалпы өлім-жітімнің саны- 21 % азайған.

Диаграмма 2. Нәресте өлім-жітімінің коэффициенті-1 жасқа дейінгі өлім-жітім деңгейін анықтайтын көрсеткіш(0 жас).0 жасқа дейінгі өлгендер санының 1000 тірі туылғандар санына қатынасымен анықталады.

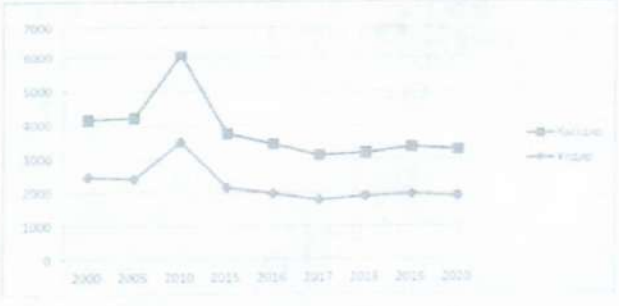
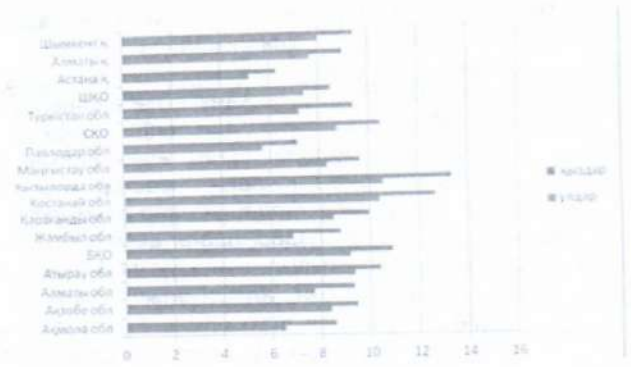


Диаграмма 3. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы нәрестелер мен балалар өлім-жітімінің коэффициенті(қыздар мен ұлдар)



Нәрестелер өлім-жітімі

Таблица 1.

Жылдар	1 жасқа дейінгі өлген балалар саны, адам			1 000 тірі туғандарға 1 жасқа дейінгі өлген балалар саны		
	барлығы	ұлдар	қыздар	барлығы	ұлдар	қыздар
Барлық халық						
2000	4 163	2 452	1 711	18.82	21.06	15.89
2005	4 213	2 406	1 807	15.15	16.81	13.38
2010	6 078	3 491	2 587	16.59	18.51	14.56
2015	3 751	2 147	1 604	9.41	10.46	8.3
2016	3 438	1 967	1 471	8.59	9.5	7.61
2017	3 109	1 771	1 338	7.93	8.74	7.06
2018	3 184	1 892	1 292	8.03	9.25	6.74
2019	3 360	1 944	1 416	8.37	9.37	7.30
2020	3 286	1 888	1 398	7.77	8.63	6.85

Таблица 2. Қала халқы.

2000	2 314	1 353	961	20.33	23.19	17.33
2005	2 711	1 553	1 158	16.63	18.5	14.64
2010	3 221	1 864	1 357	16.75	18.82	14.55
2015	2 177	1 236	941	9.66	10.63	8.62
2016	1 936	1 125	813	8.45	9.48	7.34
2017	1 700	935	765	7.48	7.96	6.96
2018	1 846	1 111	735	7.90	9.20	6.51
2019	2 057	1 176	881	8.61	9.52	6.64
2020	2 094	1 211	883	8.43	9.41	7.38

Таблица 3. Ауыл халқы

2000	1 849	1 099	750	17.17	19.88	14.32
2005	1 502	853	649	13.02	14.38	11.57
2010	2 857	1 627	1 230	16.43	18.18	14.58
2015	1 574	911	663	9.08	10.22	7.87
2016	1 502	844	658	8.77	9.53	7.95
2017	1 409	836	673	8.55	9.81	7.19
2018	1 338	781	557	8.21	9.31	7.05
2019	1 303	768	535	8.38	9.14	6.79
2020	1 192	677	515	6.84	7.52	6.11

Қорытынды: Қала халқында 2000-2020 жж. аралығындағы 1 жасқа деңгейінгі қыздардың өлім-жітімінің саны -8,12% төмендеген, ал ұлдар-10,49% төмендеген.

Ауыл халқында 2000-2020 жж.аралығындағы 1 жасқа дейінгі қыздардың өлім-жітімінің саны -31,33% төмендеген, ұлдар-38,39% төмендеген.

-Неонатальды өлім-жітім- ерте – алғашқы 7 тәулікте (0-6 күн), кеш –7 және 28 толық күн аралығында (7-27күн)

-Постнеонатальды өлім-жітім- (28 күннен 1 жасқа дейінгі)

-Перинатальды өлім-жітім – ұрықтың босану кезіндегі және перинатальды кезеңде (жүктіліктің 22 аптасынан бастап,туылғаннан кейінгі 7 күн аралығы)

Соның бірі Батыс Қазақстан облысының «№ 5 қалалық емханасының» 2018-2020 жж. аралығындағы нәресте өлім-жітімінің статистикасы:

Нәрестелер өлім-жітімі (2018-2020ж)

Таблица 4.

	2018	2019	2020
Бала өлімі	7-0,5	13-0,8	20-1,2
Соның ішінде нәрестелер өлім-жітімі	5-3,8	10-7,8	17-13,2
Ерте неонатальды	1-0,8	4-3,1	7-5,4
Кеш неонатальды	3-2,3	3-2,3	2-1,5
Постнеонатальды	1-0,8	-2,3	8-6,2

Қорытынды: Нәресте өлім-жітімінің ерте неонатальды сатысында -4.6% көбейген, кеш неонатальды -0.8% төмендеген, постнеонатальды – 5.4% көбейген.

Нәрестелер өлім-жітімінің себептері (2018-2020жж.)

Таблица 5.

2018	2019	2020
Тыныс алу жүйесінің синдромдары -3-75%	Жеке перинатальды кезеңде-4-36,4% соның ішіндегі тыныс алу бұзылыстарының синдромы-3-75% Неонатальды аспирациялы синдром-1-25%	Жеке перинатальды кезеңде-10-58,8% соның ішіндегі тыныс алу бұзылыстарының синдромы-7-70% Бронхоөкпелік дисплазия-2-20%,жаңа туған баладағы некротикалық энтероколит-1-10%
Туа пайда болған ақау-1-20%	Туа пайда болған ақау -4-36,4%	Туа пайда болған ақау-6-35,3%
Интоксикация.Сепсис.Септикопиемия-1-16,7%	Тыныс алу жолдарының (пневмония)-2-18,2%	Жүйке жүйесінің аурулары-1-5,9%

Қорытынды: 2018-2020 жж.аралығындағы нәрестелердің жеке перинатальды кезеңдегі тыныс алу синдромдарынан өлім-жітім көрсеткіші -5% төмендегенін, туа пайда болған ақау бойынша -15,3% көтерілгенін байқаймыз.

Жақсарту, өлім-жітімді қалай азайтамыз деген сауалға келетін болсақ, санитарлық тазалық, таза ауыз, суға қол жетімділік, иммундауға қарсы жұқпалы аурулар, және басқа да шаралар сәбилер өлімінің жоғары деңгейін төмендетуге көмектеседі. Қазақстанда нәрестелер мен балалар өлімін төмендетуге амбулаторлық қабылдау, үйде патронаждық қызмет көрсету және кең таралған аурулар мен жарақаттарды емдеу, сондай-ақ ана, әке, бала және отбасын жоспарлау мәселелерін қамтыған алғашқы медициналық-санитарлық көмегі (АМСК) үлкен үлес қосып келеді. АМСК жүктілік кезінде және босанғаннан кейін күтім жасау, сондай-ақ отбасыны жоспарлау, оның ішінде

контрацепция ұсыну бойынша қызметтерін артса, балалар өлімінің төмендейтіні айдан анық. Сондай-ақ, бағалау патронаждық қатысудың жаңа моделі сыналған өңірлерде, ауылдық аудандарды қоса алғанда әдейі болмаған жарақаттан, пневмониядан өлім-жітімнің едәуір төмендегенін көруге болады.**Патронаждың дәстүрлі моделі** әлеуметтік мәселелерді емес, баланың дамуының медициналық аспектілерімен жұмыс істеуге және бағалауға бағытталып келеді.Сонымен қатар патронажды қызмет көрсетуде әмбебап моделінің денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі медбикелер немесе делдалдардың - тиісті учаскелердегі денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің тіркеу учаскесінде әрбір баланы қамти отырып, әр отбасы өз денсаулықтарымен қатар бала денсаулығына қатты мән берсе дейміз.

Бұл мақала негізінде ресми мәліметтеріне талдау жасай отырып Қазақстан бойынша нәрестелер өлім-жітімінің себеп салдарын анықтауға бағыттадық. 1 жасқа дейінгі нәрестелер өлім-жітімі-бұл демографиялық факторлардың бірі, еліміздің экономикалық және әлеуметтік жағдайының дамуына, білім дәрежесі мен мәдениетіне, қоршаған ортаның ластануына, қол жетімді медициналық көмекке, материалдық игіліктердің қоғамындағы үлестірілуіне тікелей әсер етеді. Соның бірі Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледж студенттерінің әсіресе қыздардың болашақ дені сау ана атануына себепкер болатын жағдайлар –жоспарсыз құрылған ерте жүктіліктен,жасанды түсік тастаудан, түрлі вирусты инфекциялардан, дұрыс тамақтану, әсіресе «Акушер»ісі мамандықтарын еріктілермен өткізілетін жиналыстарда жыныстық қатынас арқылы берілетін түрлі инфекциялық ауруларлардан сақтану, алдын алу, қорғану ақпараттарымен, теориялық сабақтарда көрші шет елді мекендерден алынған арнайы ақпараттанған жүйе бойынша электронды оқулықтармен, онлайн мастер кластарымен, клиникалық сабақтарда акушер-гинекология бөлімшелерінде, босану залдарындағы дәрігерлермен бірге дағдыларды көре отырып, шала туылған немесе нәрестелердің өлім-жітімінен алдын алып жатырмыз.

This article analyzes the main official data and sets the task to determine the causes of infant mortality in Kazakhstan Infant mortality is one of the demographic factors that directly affect the development of the economic and social situation in the country, the level of education and culture, environmental pollution, the availability of medical care, and the distribution of material wealth in society. One of them is the conditions that cause the students of West Kazakhstan Higher Medical College, especially girls, to become healthy mothers in the future - from unplanned early pregnancy, artificial abortion, various viral infections, proper nutrition, especially various infectious diseases transmitted through sexual intercourse at meetings held with volunteers of "Obstetrician" professions. prevent diseases, prevention and protection information, e-textbooks on a special information system obtained from neighboring foreign settlements in theoretical classes, online master classes, in clinical classes in obstetrics and gynecology departments, with doctors in delivery rooms, preventing premature births or the death of babies.

Әдебиеттер тізімі:

1. ISSN: 2524-0684eISSN: 2524-0692
2.Энциклопедия site:kk.wikikou.ru Зерттеу (https://kk.wikikou.ru/wiki/Infant_mortality) 3. Туылу (stat.gov.kz) 4. Аубакирова А. К. Медико-организационные технологии снижения неонатальной смертности в родовспомогательных учреждениях
3 уровня //Медицина. - 2014. - №5. - С. 50-51. 5.Журнал «Экология и гигиена» Медицинский университет Караганды.с 28. 6. 2 Ведение больного младенца в возрасте от 0 до 2 месяцев. ВОЗ, 2008 http://wwww.who.int (дата обращения: 16.12.2019 г.) 7. Ембергенова М. Х. Опыт Казахстана в выполнении
4 цели тысячелетия по снижению смертности детей от 0 до 5 лет за период с 1990 по 2015 годы /М. Х. Ембергенова, Т. К. Чувакова, Б. Т. Карин //Педиатрия и детская хирургия. - 2016. - №3. - С. 65-69.
8.Интегрированное ведение болезней детского возраста от 2 месяцев до 5 лет. ВОЗ, 2005. http://www.who.int (дата обращения: 16.12.2019 г.)
9. Кизатова С. Т. Анализ перинатальных причин в структуре младенческой смертности по Карагандинской области /С. Т. Кизатова, Н. И. 2016. Дюсембаева //Медицина и экология. №93. - С. 71-74.
10. Кизатова С. Т. Перинатальные аспекты в структуре младенческой смертности по карагандинской области / С. Т. Кизатова, М. М. Тусупбекова, Н. И. Дюсембаева //Педиатрия и детская хирургия Казахстана.- 2016. - №3. - С. 92-94.
11. Перинатальные аспекты в структуре младенческой смертности по Карагандинской области за 2016 год /С. Т. Кизатова, Н. И. Дюсембаева, Б. Т. Тукбекова, Р. А. Ниетбаева // Медицина и экология. - 2017.-№3. - С. 63-66.
12. Попова Л. А. Младенческая смертность: история, современные тенденции, региональная специфика. - Сыктывкар, 2010. - 32 с.
13 Преждевременный дородовый разрыв плодных оболочек при недоношенной беременности /Г. Б. Бапаева, К. Б. Джаманаева, Т. К. Чувакова, С. Н. Кулбаева //Наука и здравоохранение. - 2015.- №3. - С. 6-10.
14. Снижение младенческой смертностиосновная задача охраны доровья детей /Р. З. Боранбаева, С. Г. Анохина, К. Ж. Биржанова, Ж. Ж.Садуова //Педиатрия и детская хирургия Казахстана. - 2019. - №2. - С.7-10.
15. Состояние и перспективы развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК
16.Чувакова Т. К. Итоги внедрения международных критериев живорождения и мертворождения в статистическую отчетность Республики Казахстан: ключевые интервенции, результа ты /Т. К. Чувакова, Г. О. Абуова, И. В. Ивасив // Вестн. ННЦМД. - 2013.-№1.- С. 9-17.
17.https://www.unicef.org/ 18. https://kaz.caravan.kz/zhangalyqtar/

4 (55) 2022 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КӘСІБИ ЖУРНАЛ

Мейірбике Ісі

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО



Жаңа жыл құтты болсын!

Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждёт.
Пусть будет добрым, самым лучшим
Пришедший нынче Новый год!
С новым 2023 годом!



e-mail: meyirbikeici@mail.ru

100019, Караганда, ул.Университетская 25а
телефон 50-21-71